テスト用架空事例

認定結果(テスト用設定)

要介護度	要介護3
認定日	令和8年9月24日(テスト用)
認定の有効期間	令和8年10月1日～令和9年9月30日(12か月) (テスト用)

認 定 調 査 票 (概 況 調 査)

Ⅰ 調査実施者(記入者)

実施日時	令和8年9月2日 (テスト用)
実施場所	自宅
記入者氏名・所属	＊＊＊＊(テスト用)

Ⅱ 調査対象者

過去の認定	更新申請(前回:要介護2)		
対象者氏名	松尾 ヨシ (まつお よし)	性別	女
生年月日	昭和13年(1938年)6月15日	年齢	88歳
現住所	○○県○○市＊＊＊＊(テスト用)		
家族等連絡先	＊＊＊＊(テスト用)		

Ⅲ 現在受けているサービスの状況

介護給付 通所介護(週3回・入浴あり)、短期入所生活介護(月4日)、訪問介護(身体介護・週2回・服薬の確認)。

Ⅳ 置かれている環境等(調査対象者の家族状況、調査対象者の居住環境、日常的に使用する機器・器械の有無等)

家族状況	未婚の長男(56歳)と二人暮らし。長男は夜勤のある警備の仕事をしている。主な介護者は長男。ほかに頼れる親族はいない。
居住環境	築45年の木造平屋の持ち家。物が多く、台所や廊下が散らかっている。
使用している機器等	なし。
生活歴	農家に生まれ、結婚後は夫と小さな畑を耕しながら、近くの工場でも働いた。夫は15年前に死去。
本人・家族の主訴	本人:「ここは私の家じゃない。家に帰る。」 長男:「仕事を辞めるわけにはいかない。夜勤の日に母を一人にするのが不安で、自分も眠れない。」

認定調査票(基本調査)

テスト用架空事例

該当する選択肢を〇で囲んでいます。

第1群 身体機能・起居動作	
1-1 麻痺等の有無 (複数選択可)	(ない) 左上肢　右上肢　左下肢　右下肢　その他(四肢の欠損)
1-2 拘縮の有無 (複数選択可)	(ない) 肩関節　股関節　膝関節　その他(四肢の欠損)
1-3 寝返り	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-4 起き上がり	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-5 座位保持	(できる) 自分の手で支えればできる　支えてもらえればできる　できない
1-6 両足での立位保持	(支えなしでできる) 何か支えがあればできる　できない
1-7 歩行	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-8 立ち上がり	(つかまらないでできる) 何かにつかまればできる　できない
1-9 片足での立位	支えなしでできる (何か支えがあればできる) できない
1-10 洗身	介助されていない (一部介助) 全介助　行っていない
1-11 つめ切り	介助されていない　一部介助 (全介助)
1-12 視力	(普通(日常生活に支障がない)) 約1m離れた視力確認表の図が見える 目の前に置いた視力確認表の図が見える　ほとんど見えない 見えているのか判断不能
1-13 聴力	(普通) 普通の声がやっと聞き取れる　かなり大きな声なら何とか聞き取れる ほとんど聞えない　聞えているのか判断不能
第2群 生活機能	
2-1 移乗	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-2 移動	(介助されていない) 見守り等　一部介助　全介助
2-3 えん下	(できる) 見守り等　できない
2-4 食事摂取	介助されていない (見守り等) 一部介助　全介助
2-5 排尿	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-6 排便	介助されていない　見守り等 (一部介助) 全介助
2-7 口腔清潔	介助されていない (一部介助) 全介助
2-8 洗顔	介助されていない (一部介助) 全介助
2-9 整髪	介助されていない (一部介助) 全介助
2-10 上衣の着脱	介助されていない (見守り等) 一部介助　全介助
2-11 ズボン等の着脱	介助されていない (見守り等) 一部介助　全介助
2-12 外出頻度	(週1回以上) 月1回以上　月1回未満
第3群 認知機能	
3-1 意思の伝達	調査対象者が意思を他者に伝達できる (ときどき伝達できる) ほとんど伝達できない　できない
3-2 毎日の日課を理解	できる (できない)
3-3 生年月日や年齢を言う	できる (できない)
3-4 短期記憶	できる (できない)
3-5 自分の名前を言う	(できる) できない
3-6 今の季節を理解する	できる (できない)
3-7 場所の理解	できる (できない)
3-8 徘徊	ない (ときどきある) ある

3-9 外出すると戻れない	ない　ときどきある　(ある)　テスト用架空事例
第4群 精神・行動障害	
4-1 物を盗られたなどと被害的になる	ない　ときどきある　(ある)
4-2 作話	ない　(ときどきある)　ある
4-3 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になる	(ない)　ときどきある　ある
4-4 昼夜の逆転がある	ない　(ときどきある)　ある
4-5 しつこく同じ話をする	ない　ときどきある　(ある)
4-6 大声をだす	ない　(ときどきある)　ある
4-7 介護に抵抗する	ない　ときどきある　(ある)
4-8 「家に帰る」等と言い落ち着きがない	ない　(ときどきある)　ある
4-9 一人で外に出たがり目が離せない	ない　(ときどきある)　ある
4-10 いろいろなものを集めたり、無断でもってくる	(ない)　ときどきある　ある
4-11 物を壊したり、衣類を破いたりする	(ない)　ときどきある　ある
4-12 ひどい物忘れ	ない　ときどきある　(ある)
4-13 意味もなく独り言や独り笑いをする	(ない)　ときどきある　ある
4-14 自分勝手に行動する	ない　(ときどきある)　ある
4-15 話がまとまらず、会話にならない	ない　(ときどきある)　ある
第5群 社会生活への適応	
5-1 薬の内服	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-2 金銭の管理	介助されていない　一部介助　(全介助)
5-3 日常の意思決定	できる(特別な場合でもできる)　特別な場合を除いてできる　(日常的に困難)　できない
5-4 集団への不適応	ない　(ときどきある)　ある
5-5 買い物	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)
5-6 簡単な調理	介助されていない　見守り等　一部介助　(全介助)

その他 過去14日間に受けた特別な医療

□点滴の管理　□中心静脈栄養　□透析　□ストーマ(人工肛門)の処置　□酸素療法　□レスピレーター(人工呼吸器)
□気管切開の処置　□疼痛の看護　□経管栄養　□モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)　□じょくそうの処置
□カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)

日常生活自立度

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)	自立　J1　J2　(A1)　A2　B1　B2　C1　C2
認知症高齢者の日常生活自立度	自立　Ⅰ　Ⅱa　Ⅱb　(Ⅲa)　Ⅲb　Ⅳ　M

認定調査票（特記事項）

テスト用架空事例

第1群 身体機能・起居動作	体の動きは年齢相応で、屋内は一人で歩ける。 1-10 自宅では入浴を嫌がり、通所介護で背中と足を洗う介助を受けている。 1-11 爪切りを嫌がるため、通所介護の職員が声をかけながら切っている。
第2群 生活機能	2-4 食べることに集中できず、途中で席を立つ。声かけと見守りが必要。 2-5・2-6 トイレの場所がわからなくなり失禁することがあり、後始末を長男が行う。 2-7〜2-9 声をかけて道具を渡し、一緒に行えばできる。 2-10・2-11 服の順番がわからなくなるため、長男が声をかけて見守る。
第3群 認知機能	3-1 自分から話すが、話がそれやすく、要件が伝わりにくいことがある。 3-3 年齢を「60歳」と答えた。3-6 季節を答えられなかった。3-7 自宅を「よその家」と話す。 3-9 この半年で2回、近所で迷い、警察に保護された。
第4群 精神・行動障害	4-1 「財布を盗られた」と長男を責めることが週に数回ある。 4-4 夜中に起きて家の中を歩き回る日が、週に1〜2回ある。 4-7 入浴や着替えを強く拒むことがある。 4-8・4-9 夕方になると「家に帰る」と言って外に出ようとする。
第5群 社会生活への適応	5-1 薬を管理できず、長男と訪問介護員が飲み込むまで確認している。 5-2 金銭は長男が管理している。 5-4 通所介護で、ほかの利用者と言い争いになることがある。 長男は夜勤のある仕事を続けており、介護の負担と睡眠不足が大きい。
特別な医療	該当なし。

主 治 医 意 見 書

テスト用架空事例

申請者	松尾 ヨシ (女・88歳) 医療機関名・医師氏名:＊＊＊＊(テスト用)

1. 傷病に関する意見

(1)診断名	発症年月日
1. アルツハイマー型認知症(中等度)	約5年前
2. 高血圧症	約20年前
(2)症状としての安定性	安定
(3)経過及び治療内容	約5年前に発症。認知機能の低下はゆるやかに進んでいる(HDS-R 11点)。この1年で物盗られ妄想、夜間の歩き回り、帰宅願望が目立つようになった。身体の病状は安定している。投薬:メマンチン、降圧薬、睡眠導入薬(頓用)。

2. 特別な医療(過去14日間以内に受けた医療)

なし

3. 心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等	障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度):A1 認知症高齢者の日常生活自立度:IIIa
(2)認知症の中核症状	短期記憶:問題あり/日常の意思決定:見守りが必要/意思の伝達:時々伝えられる
(3)認知症の行動・心理症状	物盗られ妄想、昼夜逆転(週1〜2回)、帰宅願望、介護への抵抗、徘徊
(4)その他の精神・神経症状	なし
(5)身体の状態	利き腕:右/身長145cm・体重45kg/麻痺なし/関節の拘縮なし/褥瘡なし

4. 生活機能とサービスに関する意見

(1)移動	屋外歩行:介助があればしている/車いす:用いていない/歩行補助具:使用していない
(2)栄養・食生活	食事行為:見守り/栄養状態:良好/留意点:食事に集中できる環境づくり
(3)現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態とその対処方針	行方不明、転倒、介護者の介護負担の増大 → 通所介護・短期入所の活用、見守り機器、地域の見守り
(4)サービス利用による生活機能の維持・改善の見通し	期待できる
(5)医学的管理の必要性	特になし
(6)サービス提供時における医学的観点からの留意事項	その他:不安や混乱が強いときは否定せず、時間をおいて対応
(7)感染症の有無	なし

5. 特記すべき事項

BPSDのため常に見守りが必要。主介護者の長男は夜勤のある仕事を続けており、介護負担が大きい。短期入所や通所介護の活用による介護者支援が必要。